

Conceptualización de Caso

Formulación clínica · TCC / ACT / DBT

PACIENTE / INICIALES

FECHA

1. PRESENTACIÓN DEL PROBLEMA

MOTIVO DE CONSULTA EN PALABRAS DEL PACIENTE

CONDUCTAS PROBLEMA (EXCESOS Y DÉFICITS)

FRECUENCIA / INTENSIDAD / DURACIÓN

CONTEXTOS DE ACTIVACIÓN

2. FACTORES PREDISPONENTES (HISTORIA)

ANTECEDENTES RELEVANTES: HISTORIA DE VIDA, VÍNCULOS TEMPRANOS, TRAUMA

3. FACTORES PRECIPITANTES

¿QUÉ DESENCADENÓ EL PROBLEMA ACTUAL? EVENTOS, CAMBIOS, PÉRDIDAS

4. FACTORES DE MANTENIMIENTO

PENSAMIENTOS / CREENCIAS QUE SOSTIENEN EL PROBLEMA

CONDUCTAS DE EVITACIÓN O ESCAPE QUE MANTIENEN EL CICLO

FACTORES AMBIENTALES / INTERPERSONALES DE MANTENIMIENTO

Conceptualización de Caso

Formulación clínica · TCC / ACT / DBT

5. CREENCIAS NUCLEARES Y ESQUEMAS

CREENCIAS NUCLEARES IDENTIFICADAS (SOBRE SÍ MISMO, EL MUNDO, EL FUTURO)

CREENCIAS INTERMEDIAS / REGLAS / SUPUESTOS

6. FACTORES PROTECTORES Y RECURSOS

FORTALEZAS Y RECURSOS INTERNOS DEL PACIENTE

RED DE APOYO DISPONIBLE

MOTIVACIÓN PARA EL CAMBIO / VALORES CENTRALES

7. HIPÓTESIS INTEGRADORA

INTEGRACIÓN DE LOS FACTORES EN UNA NARRATIVA CLÍNICA COHERENTE

8. IMPLICANCIAS PARA EL TRATAMIENTO

FOCOS TERAPÉUTICOS PRIORITARIOS

TÉCNICAS E INTERVENCIONES A USAR

POSIBLES OBSTÁCULOS O DIFICULTADES PREVISTAS

■ La conceptualización es una hipótesis en construcción. Revisarla y actualizarla a lo largo del proceso terapéutico.